

1. Introducción y relevancia clínica

La **depresión en niños y adolescentes** es un **trastorno del estado de ánimo** caracterizado por un patrón persistente de tristeza, irritabilidad o pérdida de interés, acompañado de síntomas cognitivos, conductuales y somáticos que afectan el funcionamiento escolar, familiar y social.

Epidemiología y relevancia:

- **Prevalencia:**
 - Niños: 1–2%.
 - Adolescentes: 4–8%.
- **Inicio promedio:** entre los **11 y 14 años**.
- **Relación mujer:hombre:** 2:1 desde la pubertad.
- Alta comorbilidad con **ansiedad, TDAH, consumo de sustancias y trastornos de conducta**.
- La **depresión en la adolescencia** es uno de los principales factores de riesgo para **suicidio**, la **segunda causa de muerte** en adolescentes chilenos (MINSAL, 2024).

□ En EUNACOM, la depresión infantil y adolescente se pregunta con frecuencia en casos clínicos donde un adolescente presenta bajo rendimiento, irritabilidad, aislamiento, o ideación suicida. El desafío está en reconocer que **en la infancia predomina la irritabilidad más que la tristeza**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La depresión en la infancia y adolescencia resulta de una **interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales**.

2.1. Factores biológicos

- **Disfunción de neurotransmisores:** disminución de serotonina, noradrenalina y dopamina en el sistema límbico y corteza prefrontal.
- **Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS):** hiperactividad con aumento del cortisol plasmático.
- **Genética:** heredabilidad ~40%; antecedentes familiares de depresión aumentan el riesgo 2–4 veces.
- **Desarrollo cerebral:** maduración asincrónica entre el sistema límbico (emocional) y la corteza prefrontal (control).

2.2. Factores psicológicos

- **Estilos cognitivos negativos:** percepción de ineficacia y desesperanza.
- **Baja autoestima y escasa regulación emocional.**
- **Trauma o pérdidas tempranas.**

2.3. Factores sociales

- **Ambiente familiar disfuncional:** negligencia, abuso, violencia intrafamiliar, separación de padres.
- **Problemas escolares:** bullying, rechazo social o bajo rendimiento.
- **Redes de apoyo escasas.**
- **Factores socioculturales:** pobreza, discriminación o sobreexigencia académica.

□ En resumen, la depresión infanto-juvenil surge de una **vulnerabilidad biológica modulada por experiencias ambientales adversas**, en un contexto de desarrollo emocional inmaduro.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas por grupo etario

Edad

Manifestaciones predominantes

Preescolar Llanto fácil, irritabilidad, pérdida de interés en el juego, trastornos del sueño, ansiedad de separación, regresión conductual.

Escolar Bajo rendimiento, desmotivación, fatiga, somatización (cefalea, dolor abdominal), irritabilidad, aislamiento.

Adolescente Humor deprimido, anhedonia, culpa, baja autoestima, ideación suicida, consumo de sustancias, trastornos alimentarios.

☐ En niños, la **irritabilidad persistente** puede reemplazar la tristeza como síntoma cardinal.

3.2. Criterios diagnósticos (DSM-5)

Requiere **≥5 de los siguientes síntomas** durante al menos **2 semanas**, con **uno de los dos primeros obligatorios**:

1. Humor deprimido o **irritable** la mayor parte del día.
2. Pérdida de interés o placer en actividades habituales.
3. Alteraciones del apetito o peso.
4. Trastornos del sueño (insomnio o hipersomnia).
5. Fatiga o pérdida de energía.
6. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva.
7. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones.
8. Agitación o enlentecimiento psicomotor.
9. Pensamientos de muerte o **ideación suicida**.

El cuadro debe causar **deterioro significativo** en el funcionamiento social, escolar o familiar.

3.3. Clasificación por gravedad

Grado	Características
Leve	5–6 síntomas, leve disfunción.
Moderado	Mayor intensidad o disfunción social.
Grave	Ideación o intento suicida, síntomas psicóticos o deterioro global.

3.4. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Trastorno adaptativo	Síntomas depresivos leves tras evento estresante, de <6 meses de duración.
Trastorno distímico (depresión persistente)	Síntomas crónicos >1 año, menos intensos pero sostenidos.
Trastorno bipolar	Episodios de euforia, irritabilidad o hipomanía previos.
Trastornos de ansiedad	Predomina el miedo o preocupación más que la tristeza.
TDAH	Desmotivación e impulsividad sin anhedonia ni tristeza profunda.
Duelo normal	Reacción proporcional a pérdida, con preservación de autoestima y vínculo con otros.

□ En EUNACOM, es frecuente confundir **depresión con TDAH** o **trastorno de conducta**. El elemento diferenciador clave es la **pérdida de placer y energía**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

- **Entrevista clínica estructurada** con niño/adolescente y cuidadores.
- **Evaluación del funcionamiento global:** escuela, hogar, relaciones sociales.
- **Aplicación de instrumentos de pesquisa:**
 - **Escala de Depresión Infantil de Kovacs (CDI).**
 - **Escala de Depresión de Beck para adolescentes (BDI-II).**
 - **Inventario de Depresión Infantil de Reynolds (CDRS-R).**
 - **Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)** → evaluar riesgo suicida.

4.2. Exámenes complementarios

Solo para descartar causas médicas:

- **Hemograma y TSH** → descartar anemia o hipotiroidismo.
- **Glicemia, perfil hepático, si se sospecha fármaco o trastorno metabólico.**
- **No se recomienda neuroimagen rutinaria.**

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo es **multimodal**, priorizando la **intervención psicoterapéutica y familiar**, e incorporando fármacos cuando el cuadro es moderado o grave.

5.1. Intervenciones psicoterapéuticas

1. Psicoeducación

- Explicar que la depresión es una enfermedad, no un defecto personal.
- Educar a la familia sobre síntomas, curso y recaídas.
- Favorecer comunicación y expresión emocional.
- Promover hábitos saludables: sueño, ejercicio, alimentación.

2. Psicoterapia individual

- **Terapia Cognitivo-Conductual (TCC):**
 - Evidencia grado 1A (primera línea).
 - Se enfoca en reestructurar pensamientos negativos automáticos, mejorar resolución de problemas y motivación.
- **Terapia Interpersonal (TIP):**
 - Enfocada en relaciones y eventos vitales (duelos, conflictos familiares).
 - Particularmente útil en adolescentes.
- **Terapia familiar:**
 - Fundamental en menores de 12 años o contextos disfuncionales.
 - Fomenta apoyo parental y mejora dinámica comunicacional.

3. Intervención escolar

- Comunicación con orientadores y docentes.
- Adaptaciones: reducción de carga académica temporal, apoyo emocional.

5.2. Tratamiento farmacológico

Indicado en:

- Depresión **moderada o grave**.
- Falta de respuesta a psicoterapia tras 6–8 semanas.

- **Ideación o intento suicida activo** (siempre acompañado de psicoterapia).

a. Fármacos de elección (ISRS):

Fármaco	Edad mínima	Dosis inicial	Dosis máxima	Observaciones
Fluoxetina	≥8 años	10 mg/día	20–40 mg/día	Primer ISRS aprobado por FDA/MINSAL para uso pediátrico.
Sertralina	≥12 años	25 mg/día	100–150 mg/día	Alternativa si hay ansiedad comórbida.
Escitalopram	≥12 años	5–10 mg/día	20 mg/día	Mejor tolerabilidad en adolescentes.

□ **Fluoxetina** es el fármaco de elección según **guías MINSAL 2023**, tanto en APS como en COSAM.

b. Consideraciones generales:

- Iniciar siempre con dosis baja y subir progresivamente cada 1–2 semanas.
- Reevaluar respuesta a las 4–6 semanas.
- Mantener tratamiento **al menos 9–12 meses tras la remisión**.
- Controlar signos de **activación, irritabilidad o ideación suicida** durante las primeras semanas.

c. Fármacos no recomendados en primera línea

- **Tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina):** riesgo cardiovascular y baja eficacia en niños.
- **Benzodiacepinas:** evitar, salvo insomnio grave transitorio.

5.3. Manejo del riesgo suicida

- Evaluar riesgo en cada control (C-SSRS, verbalización directa).
 - Preguntar sin temor: “¿Has pensado en morir o hacerte daño?”.
 - Supervisión familiar estricta: eliminar medios letales (fármacos, armas).
 - Derivación urgente a **hospitalización psiquiátrica** si hay:
 - Plan suicida estructurado.
 - Intento reciente.
 - Descompensación emocional severa.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Suicidio o intento autolesivo.
- Trastornos por consumo de sustancias.
- Trastornos de conducta o antisocial.
- Abandono escolar y fracaso académico.
- Trastornos de ansiedad o bipolaridad en la adultez.

6.2. Pronóstico

- **Con tratamiento adecuado:** 70–80% responde favorablemente en 3–6 meses.
- **Riesgo de recaída:** 30–40% en 5 años, mayor si hay antecedentes familiares o comorbilidad.
- **Factores de mal pronóstico:** inicio precoz, abuso, disfunción familiar, falta de adherencia o ideación suicida persistente.

□ Un manejo precoz y multidisciplinario mejora el pronóstico académico y social, y reduce el riesgo de suicidio.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. En **niños pequeños**, la **irritabilidad** puede reemplazar la tristeza como síntoma cardinal.
 2. En **adolescentes**, sospechar depresión ante **aislamiento, bajo rendimiento o consumo de sustancias**.
 3. La **fluoxetina** es el **antidepresivo de elección** en Chile para menores de 18 años.
 4. La **TCC** y **TIP** son terapias de primera línea, incluso sin fármacos en cuadros leves.
 5. Todo paciente con **ideación suicida** debe ser evaluado en forma **presencial y urgente**.
 6. El tratamiento debe mantenerse **al menos 9 meses tras la remisión** para prevenir recaídas.
 7. La **psicoeducación familiar** mejora significativamente la adherencia y pronóstico.
-



Errores comunes

- No considerar depresión en cuadros de **irritabilidad o somatización**.
 - Indicar antidepresivos sin psicoterapia asociada.
 - Suspendir fármacos prematuramente (<6 meses).
 - Ignorar ideación suicida por temor a “estimularla”.
 - No coordinar manejo con escuela o entorno familiar.
 - Usar benzodiacepinas de forma prolongada.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **depresión infantil y adolescente** es un trastorno del ánimo con manifestaciones diferentes a las del adulto, destacando la **irritabilidad** y el **aislamiento**.
2. El diagnóstico es **clínico**, basado en criterios DSM-5, y requiere evaluar comorbilidades y riesgo suicida.
3. El tratamiento es **multimodal**, centrado en la **TCC** y la **fluoxetina** como fármaco de elección.
4. La **psicoeducación familiar y el apoyo escolar** son pilares del manejo.
5. Toda **ideación suicida** requiere evaluación urgente y manejo especializado.
6. Mantener el tratamiento por **9–12 meses** tras la remisión reduce recaídas.
7. Con detección precoz y acompañamiento, el pronóstico es favorable en la mayoría de los casos.